

magnesi) 2 giờ trước hoặc sau khi uống levofloxacin (xem *Cách dùng, liều dùng*). Muối calci ít có ảnh hưởng đến hấp thu đường uống của levofloxacin.

Sucralfat: Sinh khả dụng của levofloxacin giảm đáng kể khi dùng đồng thời với sucralfat. Nếu bệnh nhân phải dùng cả sucralfat và levofloxacin, thì nhất nên uống sucralfat 2 giờ sau khi uống levofloxacin (xem *Cách dùng, liều dùng*).

Theophylin, fenbuten hoặc các thuốc kháng viêm không steroid tương tự: Không có tương tác được động học được ghi nhận giữa levofloxacin và theophylin trong một nghiên cứu lâm sàng. Tuy nhiên, ngưỡng co giật ở não có thể giảm đáng kể khi dùng đồng thời kháng sinh nhóm quinolon với theophylin, thuốc kháng viêm không steroid hoặc các thuốc làm giảm ngưỡng co giật. Khi có sự hiện diện của fenbuten, nồng độ của levofloxacin cao hơn khoảng 13% so với khi dùng levofloxacin đơn lẻ.

Probencid và cimetidin: Qua tương kế, probencid và cimetidin có ảnh hưởng đáng kể đến sự thải trừ của levofloxacin. Độ thanh thải qua thận của levofloxacin giảm bởi cimetidin (24%) và probencid (34%). Do cả hai loại thuốc này đều có khả năng ngăn chặn sự bài tiết ở ống thận của levofloxacin. Tuy nhiên ở liều thử nghiệm trong nghiên cứu, sự khác biệt động học có ý nghĩa thống kê dường như không có ảnh hưởng trên lâm sàng.

Cần thận trọng khi dùng đồng thời levofloxacin với các thuốc có ảnh hưởng đến sự bài tiết qua ống thận như probencid và cimetidin, nhất là đối với bệnh nhân suy thận.

Thông tin liên quan khác: Các nghiên cứu dược lý lâm sàng cho thấy được động học của levofloxacin không bị ảnh hưởng ở mức độ biểu hiện trên lâm sàng khi dùng đồng thời với các thuốc sau:

- calci carbonat,
- digoxin,
- glibenclamid,
- ranitidin.

Tác dụng của levofloxacin đối với các sản phẩm thuốc khác

Ciclosporin: Thời gian bán thải của ciclosporin tăng lên 33% khi dùng đồng thời với levofloxacin.

Các thuốc đối kháng vitamin K: Các xét nghiệm đông máu (PT/INR) tăng vẫ hoặc chảy máu, có thể nghiêm trọng, đã được ghi nhận ở bệnh nhân điều trị bằng levofloxacin kết hợp với thuốc đối kháng vitamin K (như warfarin). Do đó, nên theo dõi các xét nghiệm đông máu trên bệnh nhân đã được điều trị bằng các thuốc đối kháng vitamin K (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Các thuốc làm kéo dài khoảng QT: Cũng như các kháng sinh fluoroquinolon khác, nên thận trọng khi sử dụng levofloxacin trên bệnh nhân đang dùng các thuốc làm kéo dài khoảng QT (như các thuốc chống loạn nhịp nhóm IA và III, các thuốc chống trầm cảm ba vòng, các kháng sinh nhóm macrolid, các thuốc chống loạn thần) (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc* - Kháng QT kéo dài).

Thông tin liên quan khác

Trong môi trường cứu sống tác được động học, levofloxacin không ảnh hưởng đến được động học của theophylin (là chất nền thẩm dò CYP1A2), cho thấy levofloxacin không phải là chất ức chế CYP1A2.

Các dạng khác của tương tác

Thử ăn: Không có tương tác biểu hiện trên lâm sàng với thức ăn. Do đó, có thể uống levofloxacin bất kể có dùng thức ăn hay không.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Thông tin dưới đây dựa trên dữ liệu từ các nghiên cứu lâm sàng trên 8300 bệnh nhân và kinh nghiệm sau khi đưa thuốc ra thị trường. Tần suất xuất hiện được định nghĩa theo quy ước sau: rất thường gặp (≥ 1/10), thường gặp (≥ 1/100, < 1/10), ít gặp (≥ 1/1000, < 1/100), hiếm gặp (≥ 1/10.000, < 1/1000), rất hiếm gặp (< 1/10.000), chưa rõ (không thể ước tính từ dữ liệu sẵn có).

Trong mỗi nhóm tần suất, tác dụng không mong muốn được trình bày theo mức độ nghiêm trọng giảm dần.

Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng

Ít gặp: Nhiễm nấm bao gồm nhiễm nấm *Candida*. Các chủng kháng thuốc.

Rối loạn máu và hệ bạch huyết

Ít gặp: Giảm bạch cầu. Tăng bạch cầu ưa eosin. **Hiếm gặp**: Giảm bạch cầu tiểu cầu. Giảm bạch cầu trung tính. **Chưa rõ**: Giảm toàn thể huyết cầu.

Mất bạch cầu hạt. Thiếu máu tán huyết.

Rối loạn hệ miễn dịch

Hiếm gặp: Phù mạch. Quá mẫn (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Chưa rõ: Sốc phản vệ¹ (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng

Ít gặp: Chán ăn. **Hiếm gặp**: Hạ đường huyết đặc biệt ở bệnh nhân đái tháo đường (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). **Chưa rõ**: Tăng đường huyết. Hôn mê do hạ đường huyết (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Rối loạn tâm thần *

Thường gặp: Mất ngủ. **Ít gặp**: Lo âu. Lo lắng. Căng thẳng. **Hiếm gặp**: Các phản ứng tâm thần (như ảo giác, hoang tưởng). Chấn nân. Lo lắng. Có các giấc mơ bất thường. Ác mộng. **Chưa rõ**: Rối loạn tâm thần dẫn đến hành vi tự gây nguy hiểm bao gồm có ý định tự sát hoặc cố gắng tự tử (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Rối loạn hệ thần kinh *

Thường gặp: Đau đầu, chóng mặt. **Ít gặp**: Run. Chứng khó đọc. **Hiếm gặp**: Co giật (xem *Chống chỉ định; Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). Dị cảm. **Chưa rõ**: Bệnh thần kinh cảm giác ngoại biên (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Bệnh thần kinh cảm giác vận động ngoại biên (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Rối loạn khứu giác. Rối loạn vận động. Rối loạn ngoại tháp. Mất vị giác. Bất tỉnh. Tăng áp lực nội sọ lạnh tinh.

Rối loạn thị giác *

Hiếm gặp: Rối loạn thị giác như nhìn mờ (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Chưa rõ: Mất thị lực thoáng qua (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Rối loạn tai và tai trong *

Ít gặp: Chóng mặt. **Hiếm gặp**: ù tai. **Chưa rõ**: Mất thính lực. Khảm thính.

Rối loạn tim mạch

Hiếm gặp: Nhịp tim nhanh, đánh trống ngực. **Chưa rõ**: Nhịp nhanh thất, có thể dẫn đến ngừng tim. Loạn nhịp thất và xoắn đỉnh (chủ yếu ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ khoảng QT kéo dài), điện tâm đồ khoảng QT kéo dài (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc; Quá liều và cách xử trí*).

Rối loạn mạch máu

Hiếm gặp: Hạ huyết áp. Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất. **Ít gặp**: Khó thở. **Chưa rõ**: Co thắt phế quản. Viêm phổi dị ứng.

Rối loạn tiêu hóa

Thường gặp: Tiêu chảy. Nôn. Buồn nôn. **Ít gặp**: Đau bụng. Chứng khó tiêu. Đầy hơi. Táo bón. **Chưa rõ**: Tiêu chảy - xuất huyết trong trường hợp hiếm gặp có thể là dấu hiệu của viêm ruột, bao gồm viêm đại tràng giả mạc (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). Viêm tụy.

Rối loạn gan mật

Thường gặp: Tăng men gan (ALT/AST, phosphatase kiềm, GGT). **Ít gặp**: Tăng bilirubin máu. **Chưa rõ**: Vàng da và tổn thương gan nặng, bao gồm suy gan cấp tính nặng, chủ yếu ở các bệnh nhân đã có bệnh lý nặng (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). Viêm gan.

Rối loạn da và mô dưới da *

Ít gặp: Phát ban. Ngứa. Mày dạ. Tăng tiết mồ hôi. **Hiếm gặp**: Phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và các triệu chứng toàn thân (DRESS) (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). **Chưa rõ**: Hội tử thượng bì nghiêm độ. Hội chứng Stevens-Johnson. Hồng ban da dạng. Phản ứng nhạy cảm ánh sáng (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). Viêm mạch hủy bạch cầu. Viêm miệng.

Rối loạn nội tiết

Hiếm gặp: Hội chứng tăng tiết ADH bất thường (SIADH).

Rối loạn cơ xương và mô liên kết

Ít gặp: Đau khớp. Đau cơ. **Hiếm gặp**: Rối loạn dây chằng (xem *Chống chỉ định; Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*) bao gồm viêm gân (như gân Achilles). Yếu cơ, đặc biệt quan trọng ở bệnh nhân bị nhược cơ (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). **Chưa rõ**: Tiêu cơ vân. Đứt gân (như gân Achilles) (xem *Chống chỉ định; Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*). Đứt dây chằng. Rách cơ. Viêm khớp.

Rối loạn thận và tiết niệu

Ít gặp: Tăng creatinin máu. **Hiếm gặp**: Suy thận cấp (do viêm thận kẽ).

Rối loạn khác và tại chỗ *

Ít gặp: Suy nhược. **Hiếm gặp**: Sốt. **Chưa rõ**: Đau (bao gồm đau lưng, ngực và các chi).

* Phản ứng phản vệ và giống phản vệ đôi khi có thể xảy ra ngay cả sau liều đầu tiên.

* Phản ứng da, niêm mạc có thể xảy ra ngay cả sau liều đầu tiên.

* Rất hiếm trường hợp phản ứng thuốc nghiêm trọng kéo dài (lên đến vài tháng hoặc vài năm), gây tàn phế và có khả năng không thể phục hồi ảnh hưởng đến một số, đôi khi nhiều hệ cơ quan và các giác quan (bao gồm các phản ứng như viêm gân, đứt gân, đau khớp, đau chi, rối loạn dáng đi, bệnh thần kinh liên quan đến chứng loạn cảm, trầm cảm, mệt mỏi, mất loạn giác ngửi và suy giảm thính giác, thị lực, vị giác và khứu giác) đã được báo cáo liên quan đến việc sử dụng quinolon và fluoroquinolon trong một số trường hợp bất kể các yếu tố nguy cơ đã có từ trước (xem *Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc*).

Các tác dụng không mong muốn khác liên quan đến sử dụng kháng sinh nhóm fluoroquinolon bao gồm:

- Các đột rối loạn chuyển hóa porphyrin trên bệnh nhân bị loại bệnh chuyển hóa này.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Triệu chứng: Theo các nghiên cứu về độc tính trên động vật hoặc các nghiên cứu về được lâm sàng cho thấy với liều vượt quá liều điều trị, các dấu hiệu quan trọng nhất được ghi nhận sau quá liều cấp tính của levofloxacin là các triệu chứng ở hệ thần kinh trung ương như lú lẫn, chóng mặt, suy giảm ý thức và co giật, tăng khoảng QT cũng như các phản ứng ở dạ dày-trong khi buồn nôn và ăn mòn niêm mạc. Các dấu hiệu trên hệ thần kinh trung ương bao gồm lú lẫn, co giật, ảo giác và run đã được quan sát sau khi đưa thuốc ra thị trường.

Cách xử trí: Trong trường hợp quá liều, nên điều trị triệu chứng. Cần theo dõi điện tâm đồ do khả năng kéo dài khoảng QT. Các thuốc kháng acid có thể được sử dụng để bảo vệ niêm mạc dạ dày. Thăm tặc máu, bao gồm thêm phân tích nước và thêm phân tích nước tiểu ngoại trú, không có hiệu quả trong việc loại bỏ levofloxacin ra khỏi cơ thể. Không có thuốc giải độc đặc hiệu.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC LỰU HỌC

Nhóm dược lý: Kháng sinh quinolon (phần nhóm fluoroquinolon); mã ATC: J01MA12

Cơ chế tác dụng: Là một kháng sinh diệt khuẩn fluoroquinolon, levofloxacin tác động trên phức hợp DNA-DNA-gyrase và topoisomerase IV.

Mối quan hệ PK/PD: Hoạt tính diệt khuẩn của levofloxacin phụ thuộc vào tỷ lệ của nồng độ tối đa trong huyết thanh (Cmax) hoặc diện tích dưới đường cong (AUC) và nồng độ ức chế tối thiểu (MIC).

Cơ chế đề kháng: Đề kháng levofloxacin thông qua một quá trình từng bước bởi sự đột biến vị trí đích trong cả topoisomerases loại II, DNA gyrase và topoisomerase IV. Các cơ chế đề kháng khác như rửa trôi cần thẩm thấu (thường gặp ở *Pseudomonas aeruginosa*) và cơ chế bơm thải trừ cũng có thể ảnh hưởng đến tính nhạy cảm của levofloxacin.

Kháng chéo giữa levofloxacin và các fluoroquinolon khác đã được quan sát. Do cơ chế tác dụng, thường không có kháng chéo giữa levofloxacin và các họ kháng sinh khác.

Nồng độ tối hạn: Khuyến nghị của EUCAST về nồng độ tối hạn MIC đối với levofloxacin, phân biệt các chủng nhạy cảm với các chủng nhạy cảm trung gian và các chủng kháng thuốc được thể hiện trong bảng dưới đây để kiểm tra MIC (mg/L).

Nồng độ tối hạn MIC lâm sàng của EUCAST đối với levofloxacin (phiên bản 2.0, 2012-01-01):

Chứng gây bệnh	Nhạy cảm	Đề kháng
Enterobacteriaceae	≤ 1 mg/ L	> 2 mg/ L
<i>Pseudomonas</i> spp.	≤ 1 mg/ L	> 2 mg/ L
<i>Acinetobacter</i> spp.	≤ 1 mg/ L	> 2 mg/ L
<i>Staphylococcus</i> spp.	≤ 1 mg/ L	> 2 mg/ L
<i>S. pneumoniae</i> ¹	≤ 1 mg/ L	> 2 mg/ L
Liên cầu khuẩn A, B, C, G	≤ 1 mg/ L	> 2 mg/ L
<i>H. influenzae</i> ^{2,3}	≤ 1 mg/ L	> 1 mg/ L
<i>M. catarrhalis</i> ³	≤ 1 mg/ L	> 1 mg/ L
Nồng độ tối hạn không liên quan đến loài ⁴	≤ 1 mg/ L	> 2 mg/ L
¹ Nồng độ tối hạn levofloxacin liên quan đến liều pháp liệu cao. ² Đề kháng fluoroquinolon mức độ thấp (MIC 0,12 - 0,5 mg/l của ciprofloxacin) có thể xuất hiện nhưng không có bằng chứng về việc đề kháng này có làm quan trọng lâm sàng trong nhiễm khuẩn đường hô hấp với <i>H. influenzae</i>. ³ Các chủng có giá trị MIC trên nồng độ tối hạn nhạy cảm rất hiếm hoặc chưa được báo cáo. Độ nhạy cảm với kháng sinh và kháng khuẩn đối với bất kỳ chủng phân lập nào như vậy phải được lặp lại và nếu kết quả được xác nhận, chủng phân lập phải được gửi đến phòng thí nghiệm tham chiếu. Cho đến khi có bằng chứng liên quan đến đáp ứng lâm sàng đối với các chủng phân lập được xác định với MIC trên nồng độ tối hạn đề kháng hiện tại sẽ được báo cáo đề kháng. ⁴ Nồng độ tối hạn áp dụng cho liều uống 500 mg x 1 lần đến 500 mg x 2 lần và liều tiêm tĩnh mạch 500 mg x 1 lần đến 500 mg x 2 lần.		

Tỷ lệ kháng thuốc có thể thay đổi tùy theo địa điểm và thời gian đối với một số loài vi khuẩn và nên có thông tin về tỷ lệ kháng thuốc tại địa phương, đặc biệt là các nhiễm khuẩn nặng. Cần thiết, nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn về tỷ lệ kháng thuốc tại địa phương đối với việc sử dụng thuốc trong một số bệnh lý nhiễm khuẩn vẫn chưa rõ ràng.

Những vi khuẩn nhạy cảm thông thường

Vi khuẩn hiếu khí Gram dương: *Bacillus anthracis*, *Staphylococcus aureus* nhạy cảm methicilin, *Staphylococcus saprophyticus*, *Streptococci*, nhóm C và G, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*.

Vi khuẩn hiếu khí Gram âm: *Eikenella corrodens*, *Haemophilus influenzae*, *Haemophilus para-influenzae*, *Klebsiella oxytoca*, *Moraxella catarrhalis*, *Pasteurella multocida*, *Proteus vulgaris*, *Providencia rettgeri*.

Vi khuẩn kỵ khí: *Peptostreptococcus*.

Khắc: *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci*, *Chlamydia trachomatis*, *Legionella pneumophila*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum*.

Những vi khuẩn mủ kháng thuốc có thể là vấn đề

Vi khuẩn hiếu khí Gram dương: *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus* kháng methicilin¹, *Staphylococcus* spp. âm tính coagulase.

Vi khuẩn hiếu khí Gram âm: *Acinetobacter baumannii*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter aerogenes*, *Enterobacter cloacae*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Morganella morganii*, *Proteus mirabilis*, *Providencia stuartii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*.

Vi khuẩn hiếu khí: *Bacteroides fragilis*.

Những vi khuẩn vốn đã kháng thuốc

Vi khuẩn hiếu khí Gram dương: *Enterococcus faecium*.

¹*S. aureus* đề kháng methicilin rất có khả năng đồng kháng với các fluoroquinolon, bao gồm levofloxacin.

ĐẶC TÍNH ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu: Khi dùng đường uống, levofloxacin được hấp thu nhanh và hầu như hoàn toàn với nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được trong vòng 1 - 2 giờ. Sinh khả dụng tuyệt đối khoảng 99 - 100%.

Thức ăn có ảnh hưởng ít đến sự hấp thu levofloxacin.

Trạng thái ổn định đạt được trong vòng 48 giờ sau liều 500 mg một lần hoặc hai lần mỗi ngày.

Phân bố: Khoảng 30 - 40% levofloxacin gắn kết với protein huyết thanh. Thể tích phân bố trung bình của levofloxacin khoảng 100 lít sau khi dùng liều đơn và lặp lại 500 mg, cho thấy sự phân bố rộng rãi vào các mô cơ thể.

Thấm nhập vào các mô và dịch cơ thể: Levofloxacin đã được chứng minh có khả năng xâm nhập vào niêm mạc phế quản, dịch niêm mạc biểu mô, dịch dịch bảo phế nang, mô phổi, da (dịch phỏng rộp), mô tuyến liên liệt và nước tiểu. Tuy nhiên, levofloxacin xâm nhập kém vào dịch não tủy.

Chuyển hóa: Levofloxacin được chuyển hóa đến một mức độ rất nhỏ, các chất chuyển hóa là desmethyl-levofloxacin và levofloxacin N-oxyl. Những chất chuyển hóa này giải thích cho < 5% liều dùng được đào thải trong nước tiểu. Levofloxacin ổn định về mặt hóa học lặp thể và không trải qua sự ngưng chuyển bất đối xứng.

Thải trừ: Sau khi dùng levofloxacin đường uống và đường tĩnh mạch, nó được loại bỏ tương đối chậm khỏi huyết tương (t½: 6 - 8 giờ). Sự thải trừ chủ yếu qua đường thận (> 85% liều dùng).

Tổng lượng thanh thải trung bình toàn thân của levofloxacin sau khi dùng liều duy nhất 500 mg là 175 ± 29,2 ml/phút.

Không có sự khác biệt lớn về dược động học của levofloxacin sau khi dùng đường tĩnh mạch và đường uống, cho thấy là đường uống và đường tĩnh mạch có thể thay thế cho nhau.

Tuyến tính: Levofloxacin có được động học tuyến tính trong phạm vi 50 - 1000 mg.

Độc tượng đặc biệt

Người suy thận: Dược động học của levofloxacin bị ảnh hưởng khi suy thận. Chức năng thận suy giảm, sự thải trừ và độ thanh thải của thận giảm, và thời gian bán thải tăng lên, xem bảng dưới đây:

Dược động học ở người suy thận sau khi uống liều 500 mg duy nhất

Cl _r [ml/ phút]	< 20	20 - 49	50 - 80
Cl _e [ml/ phút]	13	26	57
t _{1/2} [giờ]	35	27	9

Người cao tuổi: Không có sự khác biệt đáng kể về dược động levofloxacin giữa người trẻ tuổi và người cao tuổi, ngoại trừ những khác biệt liên quan đến độ thanh thải creatinin.

Giới tính: Phân tích riêng biệt trên đối tượng nam và nữ cho thấy sự khác biệt giới tính từ nhỏ đến cận biên về dược động học của levofloxacin. Không có bằng chứng cho thấy những khác biệt về giới tính này có liên quan đến lâm sàng.

Dữ liệu an toàn tiền lâm sàng: Dữ liệu phi lâm sàng cho thấy không có nguy cơ độc tiềm ẩn ở người dựa trên các nghiên cứu thông thường về độc tính liều đơn, độc tính liều lặp lại, khả năng gây ung thư và độc tính đối với sinh sản và phát triển.

Các nghiên cứu trên chuột cho thấy levofloxacin chỉ có hoạt tính độc quang học ở liều rất cao. Levofloxacin không có khả năng gây nhiễm độc gen nào trong thử nghiệm gây đột biến quang học và levofloxacin làm giảm sự phát triển của khối u trong nghiên cứu gây đột biến quang học.

Giống như các fluoroquinolon khác, levofloxacin cho thấy tác dụng trên sun (phồng rộp và hồng hóc) ở chuột và chó. Những phát hiện này được phát hiện nhiều hơn ở động vật còn nhỏ.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên. Hộp 6 vỉ x 10 viên.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIÊU CHUẨN: TCCS

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang

Lô B2 - B3, Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

ĐT: (0293) 3953454 Fax: (0293) 3953555

Mọi thắc mắc về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ

0292.3899000

E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vn

dhgpharma.com.vn